Check-list: Medida da pressão arterial pelo método auscultatório

Materiais necessários: álcool a 70%, algodão, bandeja, esfigmomanômetro, manguitos de diversos tamanhos, estetoscópio, fita métrica.

AÇÕES/OBSERVAÇÕES

1.. Higienizar as mãos[1]

2. Fazer a desinfecção da campânula/diafragma e das olivas do estetoscópio, com algodão embebido em álcool a 70%

3. Separar os materiais necessários para o procedimento e colocar na bandeja

4. Higienizar as mãos

5. Apresentar-se ao paciente e confirmar sua identidade usando dois identificadores[2]

6. Certificar-se de que o paciente NÃO: está com a bexiga cheia; praticou exercícios físicos, caminhada ou fisioterapia há pelo menos 60 min; ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou nos 30 minutos anteriores

7. Explicar o procedimento ao paciente: deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos em ambiente calmo; instruí-lo a não conversar durante o procedimento (o esclarecimento de dúvidas deverá ser realizado antes ou após o procedimento)

8. Higienizar as mãos

9. Medir a circunferência do braço. Método: com braço desnudo, fletido e mão na altura da cintura, meça a distância entre acrômio e olecrano e determine o ponto médio, a seguir estenda o braço ao longo do corpo e no ponto determinado meça a circunferência do braço. Com o valor obtido selecione o manguito de tamanho adequado ao braço (Tabela1)*

10. Posicionar o paciente: sentado, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (entre o 3º e o 5º espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido

11. Localizar a artéria braquial por meio da palpação. O meio da bolsa de borracha do manguito deve ser posicionado sobre a artéria.

12. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital

13. Posicionar os olhos no mesmo nível do manômetro aneroide

14. Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. Método: palpar o pulso radial e inflar o manguito até o desaparecimento do pulso, na sequência desinflar lentamente e identificar em quantos mmHg o pulso

reaparece, (correspondente à estimativa da PA sistólica), desinflar e aguardar de 15 a 30 segundos antes de iniciar a medida

15. Colocar o estetoscópio nos ouvidos com a curvatura voltada para frente

16. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula do estetoscópio sem compressão excessiva

17. Inflar rapidamente de 10 em 10 mmHg até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, obtido anteriormente

18. Proceder a deflação lentamente (velocidade de 2mmHg/segundo)

19. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é em geral fraco, seguido de batidas regulares

20. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (Fase V de Korotkoff)

21. Continuar auscultando por mais 20 - 30 mmHg para confirmar o desaparecimento do som, depois libere todo o ar do manguito.

22. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons e anotar valores da sistólica/diastólica/zero

23. Informar os valores da pressão arterial obtidos para o paciente

24. Retirar o manguito do paciente

25. Higienizar as mãos

26. Checar a realização do procedimento e proceder a anotação de enfermagem (registrar no prontuário o valor exato da pressão arterial, sem “arredondamentos”[3]

[1]Atenção aos 5 momentos de higienização das mãos: 1. Antes de tocar o paciente; 2. Antes de realizar o procedimento limpo/asséptico; 3. Após risco de exposição a fluidos corporais; 4.Após tocar o paciente; 5. Após tocar superfícies próximas ao paciente.

[2]Os identificadores podem ser: nome e data de nascimento.

[3]Exemplo de anotação de enfermagem: 26/08/2020 – 08:00h – Realizada medida da pressão arterial pelo método auscultatório, em braço esquerdo, com paciente sentado na poltrona, com resultado igual a 118X66 mmHg. Nome/COREN.

Tabela 1. Dimensões da bolsa de borracha para diferentes circunferências de braço em crianças e adultos. * Selecionar o manguito ideal: a largura da bolsa inflável deve corresponder a 40% da circunferência do braço e seu comprimento envolver pelo menos 80% do braço

Denominação do manguito	Circunferência do braço (cm)	Bolsa de borracha (cm) Largura	Bolsa de borracha (cm) Comprimento
Recém-nascido	≤ 10	4	8
Criança	11-15	6	12
Infantil	16-22	9	18
Adulto pequeno	20-26	10	17
Adulto	27-34	12	23
Adulto grande	35-45	16	32

Bibliografia:

Brandão AA, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025. Arq Bras Cardiol. 2025;122(9):e20250624. doi: https://doi.org/10.36660/abc.20250624

Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-Gomes MA, Brandão AA, Feitosa ADM, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2021;116(3):516-658. Available from: https://doi.org/10.36660/abc.20201238

Feitosa ADM, Barroso WKS, Mion DJ, Nobre F, Mota-Gomes MA, Jardim PCBD, et al. Brazilian Guidelines for In-office and Out-of-office Blood Pressu-re Measurement. Arq Bras Cardiol. 2024;121(4):e20240113. doi: https://doi.org/10.36660/abc.20240113i2